

CAPÍTULO 14.28

Vasculitis de Vaso Pequeño ANCA Positivo

PERFIL EUNACOM 1.11.1.006

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Las **vasculitis de vaso pequeño asociadas a ANCA** son un grupo de enfermedades autoinmunes sistémicas caracterizadas por la inflamación de los vasos sanguíneos de pequeño calibre (capilares, vénulas y arteriolas). Se consideran cuadros graves con una **altísima letalidad** si no se instauran medidas terapéuticas de forma precoz.

Clasificación de las Vasculitis ANCA (+)

Existen tres entidades principales dentro de este grupo, cada una con características clínicas y serológicas distintivas:

- **Poliangitis Microscópica (PAM):** También conocida como micropoliangeítis.
- **Granulomatosis con Poliangitis (GPA):** Anteriormente conocida como **Enfermedad de Wegener**. Actualmente se prefiere evitar epónimos.
- **Granulomatosis Eosinofílica con Poliangitis (EGPA):** Anteriormente conocida como **Síndrome de Churg-Strauss** o granulomatosis alérgica.

Fisiopatología y Marcadores Serológicos

El sello distintivo de estas enfermedades es la presencia de anticuerpos contra el citoplasma de los neutrófilos (**ANCA**). Estos anticuerpos activan a los neutrófilos, los cuales se adhieren a las paredes vasculares y liberan enzimas proteolíticas y especies reactivas de oxígeno, causando daño tisular.

Existen dos patrones principales en la inmunofluorescencia que se correlacionan con antígenos específicos:

TABLA 14.28.1: VASCULITIS VS PATRÓN ANCA

VASCULITIS	PATRÓN ANCA	ANTÍGENO ESPECÍFICO
Poliangitis Microscópica (PAM)	ANCA-P (Perinuclear)	Anti-mieloperoxidasa (Anti-MPO)
Granulomatosis con Poliangitis (GPA/Wegener)	ANCA-C (Citoplasmático)	Anti-proteinasa 3 (Anti-PR3)
Granulomatosis Eosinofílica (EGPA/Churg-Strauss)	ANCA-P (Perinuclear)	Anti-mieloperoxidasa (Anti-MPO)

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Para el EUNACOM, recuerda: **Wegener es la única que típicamente marca ANCA-C (PR3)**. Las otras dos suelen ser ANCA-P (MPO).

NOTA CLÍNICA

Patrón Pausi-inmune: En la biopsia renal de estas vasculitis, se observa una glomerulonefritis con escasos o nulos depósitos de complejos inmunes en la inmunofluorescencia, lo que las diferencia de otras patologías como el **Lupus Eritematoso Sistémico** o la Berget.

Manifestaciones Clínicas Generales

Aunque cada una tiene sus particularidades, comparten un tronco común de síntomas sistémicos y afectación de órganos diana:

- **Síntomas inespecíficos:** Astenia, fiebre, malestar general, mialgias y artralgias (pueden confundirse con cuadros virales al inicio).
- **Compromiso Renal:** Se manifiesta como una **Glomerulonefritis Rápidamente Progresiva (GNRP)**. En la biopsia se observan "crecientes" o semilunas en la microscopía óptica.
- **Compromiso Pulmonar:** Puede ir desde nódulos pulmonares hasta una **alveolitis hemorrágica** (hemorragia alveolar difusa), que representa una urgencia vital.

- **Vía Aérea Superior:** Rinosinusitis crónica, traqueítis y deformidad en "silla de montar" (especialmente en GPA).
- **Sistema Nervioso: Mononeuritis múltiple**, que consiste en la afectación asincrónica y asimétrica de nervios periféricos (ej. caída del pie por compromiso del nervio peroneo y mano péndula por compromiso del radial).
- **Piel:** Rash eritematoso maculopapular o púrpura palpable.

Perfiles Clínicos Específicos

1. Poliangitis Microscópica (PAM)

- **Paciente tipo:** Adulto mayor. - **Clínica:** Es la más agresiva a nivel renal y pulmonar. Suele presentarse como un **síndrome riñón-pulmón** grave (falla renal aguda + hemoptisis). No suele presentar granulomas ni asma.

2. Granulomatosis con Poliangitis (GPA / Wegener)

- **Paciente tipo:** Adulto joven, ligeramente más frecuente en hombres. - **Clínica característica:** Típicamente comienza con afectación de la **vía aérea superior** (sinusitis crónica, otitis media recurrente, epistaxis). Posteriormente progresa a compromiso renal y pulmonar (nódulos cavitados).

3. Granulomatosis Eosinofílica con Poliangitis (EGPA / Churg-Strauss)

- **Clínica característica:** Tiene un curso más subagudo o crónico. Se define por la tríada de: 1. **Asma severo** de difícil manejo. 2. Rinitis alérgica / poliposis nasal. 3. **Eosinofilia** periférica importante. - Es la que menos frecuentemente presenta falla renal grave en comparación con las otras dos.

Diagnóstico

El diagnóstico de sospecha es clínico y serológico, pero la confirmación definitiva suele requerir histología.

- **Laboratorio:** Elevación de parámetros inflamatorios (VHS, PCR), creatinina elevada, sedimento urinario activo (hematuria dismórfica, proteinuria).
- **Serología:** Test de ANCA (C-ANCA o P-ANCA).
- **Biopsia (Gold Standard):** Se debe biopsiar el órgano afectado (riñón, pulmón o nervio periférico como el nervio sural).

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Si la sospecha clínica es alta y el paciente está grave (ej. falla renal rápidamente progresiva), **no se debe retrasar el inicio del tratamiento** a la espera de los resultados de la biopsia.

Manejo y Tratamiento

El tratamiento ha cambiado drásticamente el pronóstico de estas enfermedades. Sin tratamiento, la mortalidad de la PAM o GPA alcanza el **90% en 1-2 años**.

Esquema de Tratamiento

El tratamiento se divide en fase de inducción (para frenar la inflamación aguda) y fase de mantenimiento.

- **Corticoides:** Se inician dosis altas, habitualmente **pulsos de metilprednisolona** endovenosa en la fase aguda, seguidos de prednisona oral en pauta descendente.
- **Inmunosupresores (Inducción):**
 - **Rituximab:** Anticuerpo anti-CD20, muy utilizado actualmente con excelentes resultados.
 - **Ciclofosfamida:** Fármaco clásico, muy efectivo pero con más efectos adversos a largo plazo.

- **Casos Leves:** En presentaciones muy localizadas (ej. Wegener solo nasal o Churg-Strauss sin compromiso de órgano vital), se podría considerar el uso de corticoides orales aislados, pero la mayoría requiere terapia combinada.

Pronóstico y Seguimiento

- **Remisión:** Con el tratamiento adecuado, la mayoría de los pacientes sobrevive y logra entrar en remisión.
- **Recurrencia:** Es frecuente que la enfermedad recurra (especialmente en GPA y EGPA, cerca del 50% de los casos).
- **Seguimiento:** Es fundamental el control estricto de la función renal y parámetros inflamatorios para detectar brotes de forma precoz.

NOTA CLÍNICA

El diagnóstico diferencial principal en Chile ante un síndrome riñón-pulmón o compromiso sistémico agresivo incluye el **Lupus Eritematoso Sistémico**, la enfermedad por anticuerpos anti-MBG (Síndrome de Goodpasture) y, en ciertos contextos, infecciones graves o vasculitis por drogas.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Paciente de 35 años con rinosinusitis crónica que evoluciona con falla renal aguda y hemoptisis. ANCA-C positivo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Vasculitis de Vaso Pequeño ANCA Positivo. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Tres vasculitis ANCA positivo: PAM (ANCA-P), Wegener (ANCA-C), Churg-Strauss (ANCA-P)
- Sin tratamiento: 90% letalidad en 1-2 años; con tratamiento la mayoría sobrevive
- Glomerulonefritis rápidamente progresiva crescéntica pauci-inmune es la afectación renal típica
- Wegener: joven, hombre, parte con rinosinusitis crónica; Churg-Strauss: asma severo + eosinofilia
- PAM: adulto mayor, síndrome riñón-pulmón agresivo
- Diagnóstico: biopsia confirma, pero no esperar para tratar ante sospecha clínica + ANCA positivo
- Tratamiento: corticoides endovenosos + rituximab o ciclofosfamida

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (VASCULITIS DE VASO PEQUEÑO ANCA POSITIVO)

PREGUNTA 1

Paciente de 35 años con rinosinusitis crónica que evoluciona con falla renal aguda y hemoptisis. ANCA-C positivo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- ☐ A) Poliangeítis microscópica
- ☐ B) Granulomatosis con poliangeítis (Wegener)
- ☐ C) Churg-Strauss
- ☐ D) Poliarteritis nodosa
- ☐ E) Síndrome de Goodpasture

PREGUNTA 2

Paciente con asma de difícil manejo, rinitis alérgica importante y eosinofilia marcada. ANCA-P positivo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- ☐ A) Poliangeítis microscópica
- ☐ B) Granulomatosis de Wegener
- ☐ C) Granulomatosis eosinofílica con poliangeítis (Churg-Strauss)
- ☐ D) Asma bronquial
- ☐ E) Poliarteritis nodosa

PREGUNTA 3

¿Cuál es el patrón de la glomerulonefritis en las vasculitis ANCA positivo en la inmunofluorescencia?

- ☐ A) Depósito granular de IgA
- ☐ B) Depósito lineal de IgG
- ☐ C) Patrón pauci-inmune (sin depósito de complejos inmunes)
- ☐ D) Depósito de C3 solamente
- ☐ E) Depósito de IgM en mesangio

RESUMEN: VASCULITIS DE VASO PEQUEÑO ANCA POSITIVO

Las tres vasculitis ANCA positivo son: poliangeítis microscópica (PAM, ANCA-P/anti-MPO), granulomatosis con poliangeítis (Wegener, ANCA-C/anti-PR3) y granulomatosis eosinofílica con poliangeítis (Churg-Strauss, ANCA-P/anti-MPO). Son enfermedades graves con alta letalidad sin tratamiento (90% muerto en 1-2 años), pero con tratamiento la mayoría sobrevive e incluso puede lograr remisión permanente. La clínica compartida incluye: síntomas inespecíficos iniciales, glomerulonefritis rápidamente progresiva (crescéntica, pauci-inmune), rinosinusitis/traqueítis, alveolitis hemorrágica, mononeuritis múltiple y rash. La PAM es más agresiva en adultos mayores; el Wegener afecta a pacientes jóvenes, más hombres, partiendo con rinosinusitis crónica; el Churg-Strauss es más lento con asma importante, rinitis alérgica y eosinofilia. El diagnóstico se confirma con biopsia. El tratamiento es corticoides endovenosos más inmunosupresores (rituximab o ciclofosfamida). En casos leves de Wegener o Churg-Strauss pueden usarse solo corticoides orales.